Station 1

Du är läkare på en medicinavdelning.

Du har ansvar för en 52-årig patient som lagts in på avdelningen för 2 dagar sedan med diagnosen pneumoni och fått Bensylpencillin iv.

Patienten har fortfarande feber, är allmänpåverkad och har 2 l syrgas på grund av måttlig hypoxi. Inskrivningsjournalen är mycket kortfattad och det saknas mycket information.

Luftvägsprovet från inkomstdagen visar legionella, vilket klassas som en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen.

Du ska:

- **Ta en kompletterande strukturerad anamnes utifrån diagnosen legionellapneumoni**
- **Ställa frågor om tänkbara smittkällor**
- **Ge patienten information om sjukdomen och smittvägar**
- **Ta ställning till fortsatt antibiotikabehandling**

Du ska INTE göra kroppsundersökning med status.
Du ska INTE ordinera ytterligare provtagning.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 2

Du är primärjour medicin. Klockan är strax över midnatt och din bakjour har precis meddelat att hen lägger sig. Nu går sökaren, ett nummer du inte känner igen.

Inne på rummet finns det en telefon. Ring tillbaka, och hör vad det gäller.

Du har en dator och tillgång till internet.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 3

Du träffar en 70-årig, fd rökare med 45 paketår, som sista månaderna har hostat blod vid upprepade tillfällen. Patienten förnekar feber, har ett CRP på 7 och du bedömer att en lunginflammation är osannolik. Patienten har genomfört en lungröntgen.

Röntgensvar:

Centralt i höger ovanlob finns ett 4 cm stort rundat infiltrat. Prominent höger lunghilus. Ingen pleuravätska.

Din uppgift är att

- **informera om röntgenfyndet**
- **berätta kortfattat för patienten om fortsatt utredning.** Var tydlig med vilken undersökning som ska göras som nästa steg och vem som kommer att ansvara för fortsatt utredning.

Du behöver <u>inte</u> komplettera anamnes med avseende på symtombild och rökvanor!

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 4

På din vårdcentral kommer en 50-årig patient på återbesök, chef på ett mindre tryckeri, gift, tidigare frisk.

Vid hälsokontroll tre månader tidigare diagnos typ 2 diabetes, hade inga subjektiva symtom. Ville undvika tabletter och fick råd om kost och motion av läkare & dietist.

	Vid diagnos (3 mån sedan)	Idag
Vikt (kg)	92	91
BMI (kg/m^2)	28	28
Faste b-glukos (ref 4,2–6,3 mmol/L)	8,1	7,9
HbA1c (behandl. mål <42 mmol/mol)	61	59

<u>Din uppgift är att:</u>

- **Ta aktuell anamnes.**

- **Informera om behandlingseffekten av kost och motion och att man nu bör lägga till Metformin till måltider (börja med 500 mg till middagen och öka till 500 mg till frukost och middag efter 2 veckor om det går bra).**

- **Informera patienten om verkningsmekanism, biverkningar och risker med den nya behandlingen samt svara på eventuella frågor.**

Receptskrivning ingår inte i momentet.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 5

Du är AT läkare och arbetar idag på akuten. Du ombeds undersöka en patient som inkommer på grund av hjärtrusningar och snabb puls.

Din uppgift blir att ta anamnes och föreslå fortsatt utredning och behandling.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 6

Du är läkare på en vårdcentral. Din nästa patient är en 40-årig man/kvinna som undrar varför det är viktigt att vara fysiskt aktiv och vill ha råd om hur man kan börja med fysisk aktivitet.

Uppgifter:

1. **Tag en relevant anamnes för frågeställningen.**
2. **Förklara vikten av fysisk aktivitet för patientens hälsa.**
3. **Ge specifika och individuellt anpassade råd om fysisk aktivitet baserat på generella rekommendationer i FYSS.se.**

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 7

VILOSTATION

Station 8

63-åring, tidigare storrökare men nu slutat för ett halvår sedan. Medicinerat med Enalapril sedan länge och senaste året Metformin.

Hen upplever obehag i vänster underben och fot vid promenader sedan senaste månaden.

Initial misstanke om DVT respektive kompartment-syndrom har avskrivits.

Uppgiften är att komplettera anamnes samt att genomföra diabetesstatus inklusive perifert kärlstatus av fötterna samt informera patienten om din bedömning och fortsatt handläggning.

Övrig klinisk undersökning och behandlingsförslag <u>ingår ej</u> i uppgiften.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 9

En 60-årig tidigare frisk lokförare söker hälsocentralen på grund av störande snarkning. Hustrun brukar knuffa i honom då hon har märkt att han har andningsuppehåll, särskilt om han sover på rygg. Patienten själv tycker att han sover ”ganska bra” men han är trött på morgonen och kan ibland känna sig hängig dagtid. Han har aldrig rökt men dricker gärna öl/vin till maten på helgerna.

I status: AT: gott och opåverkat. MoS: normalt fynd. Thyreoidea: ej förstorad.

BT: 145/95. BMI 29.

Din uppgift är att:

1. **Informera om diagnosmisstanke i relation till sjukdomsbild**
2. **Ge allmänna råd och motivera varför**
3. **Informera/motivera angående eventuell utredning/uppföljning**

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 10

Du arbetar som underläkare på en hälsocentral. Nästa patient är en 50-årig kvinna/man som är nyinflyttad i regionen (saknar journalupplysningar). I bokningsunderlaget inför besöket står ”trötthet/orkeslöshet” anfört som kontaktorsak.

Inför besöket har blodtryck och puls registrerats.

Blodtryck 140/9o

Puls 95, Regelbunden.

Du behöver inte göra någon statusundersökning. Auskultation av hjärta och lungor är normala, andningen obesvärad i vila, buken är mjuk och oöm och inga patologiskt förstorade lymfkörtlar palperas på överkroppen.

Din uppgift är att ta anamnes, föreslå tänkbara arbetsdiagnoser och utifrån dessa ta beskriva för patienten vilken vidare handläggning du rekommenderar.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 11

Din nästa patient på hälsocentralen är en 75-årig kvinna. Hon kommer till dig då hon misstänker att hon har fått en biverkan av en blodtrycksmedicin hon fått för en månad sedan.

Undersökningsfynd före besöket:

- Blodtryck: 120/70 mmHg
- EKG: sinusrytm, puls 70/minut
- Normala rutinprover inklusive Kreatinin, Kolesterol, HbA1C
- Urinsticka normal

Du ska:

- **Ta en adekvat anamnes, både bakgrund och aktuellt problem**
- **Bedöma och informera patienten om det kan vara en läkemedelsbiverkan**
- **Bedöma om medicinändring är nödvändig, ändra i så fall i samråd med patienten**

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 12

Du jobbar på akuten en helg på ett mindre sjukhus med begränsad tillgång på till exempel ultraljud, som kan genomföras tidigast morgonen därpå. Akuta röntgenundersökningar och blodprover går att få.

Från triagen får du en patient med helt stabila vitalparametrar där sjuksköterskan skrivit ”misstänkt DVT”.

Du ska:

- **Ta en kort och riktad anamnes**
- **Informera patienten om din bedömning och vidare handläggning**
- **Ordinera vidare utredning och behandling till sköterska**

Du ska INTE göra någon statusundersökning

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 13

Du träffar en 56 årig man/kvinna på ett planerat återbesök efter DC konvertering av ett förmaksflimmer på en medicinmottagning. I labstatus noteras bland annat lätt förhöjda levertransaminaser samt ett PEth på 1.1 (= kraftigt förhöjt). Ett BT taget av sjuksköterska innan besöket är 160/90. EKG visar sinusrytm fr 82.

Din uppgift blir att informera patienten om dessa fynd och ställa relevanta följdfrågor samt tillsammans med patienten upprätta en behandlingsplan.

Status ingår ej.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 14

Du kommer in på en vårdsal och hittar en till synes livlös person på golvet.

Vad gör du?

(Patienten är bekräftat COVID-negativ)

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 15

VILOSTATION